

NEUROLOGIE & NEUROCHIRURGIE

Fiches QE Haute Fréquence — FMPM 2025-26 — Version 1

Cross-match : 750 QEs officielles (2017→2025) × Cours AIO Neuro + Neurochir (2 PDF officiels)

Pr. Chraa, Pr. Louhab (Neuro) • Pr. Ait Benali, Pr. Ghannane, Pr. Benantar, Pr. Laghmari, Pr. Farrouk (Neurochir)

PARTIE 1 — CLASSEMENT DES LEÇONS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

Classement basé sur la fréquence réelle dans 750 QEs (15 sessions).

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
1	Pathologies tumorales du SNC	88 Q	Pr. Ait Benali / Benantar
2	Pathologies infectieuses du SNC (fusion)	83 Q	Pr. Benantar / Louhab
3	Pathologies traumatiques (TC + rachis)	71 Q	Pr. Ait Benali
4	Pathologies neuromusculaires	62 Q	Pr. Louhab
5	Les épilepsies	42 Q	Pr. Chraa
6	Pathologies vasculaires intracrâniennes	35 Q	Pr. Ghannane
7	Neuro-Behçet	32 Q	Pr. Chraa
8	Les démences	31 Q	Pr. Chraa
9	Les AVC ischémiques	31 Q	Pr. Chraa
10	Les hydrocéphalies	29 Q	Pr. Laghmari
11	Neuropathies périphériques (+ Guillain-Barré)	25 Q	Pr. Louhab
12	La SEP	24 Q	Pr. Chraa
13	Le syndrome parkinsonien	24 Q	Pr. Chraa
14	Céphalées et algies de la face	22 Q	Pr. Chraa
15	Spina bifida	19 Q	Pr. Laghmari
16	Malformations de la charnière cranio-cervicale	19 Q	Pr. Laghmari
17	La SLA	17 Q	Pr. Louhab
18	Syndrome de compression médullaire	17 Q	Pr. Ghannane
19	Les craniosténoses	15 Q	Pr. Farrouk
20	Ataxies cérébelleuses	14 Q	Pr. Louhab
21	Sciatique par hernie discale	13 Q	Pr. Ghannane
22	Syndrome de la queue de cheval	13 Q	Pr. Ghannane

PARTIE 2 — MOYENNE DE QUESTIONS PAR LEÇON PAR EXAMEN

Statistiques calculées sur 15 sessions, chaque examen ~50 questions.

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'exam
Pathologies tumorales du SNC	88	5.87	11.7%
Pathologies infectieuses du SNC (fusion)	83	5.53	11.1%
Pathologies traumatiques (TC + rachis)	71	4.73	9.5%
Pathologies neuromusculaires	62	4.13	8.3%
Les épilepsies	42	2.80	5.6%
Pathologies vasculaires intracrâniennes	35	2.33	4.7%
Neuro-Behçet	32	2.13	4.3%
Les démences	31	2.07	4.1%
Les AVC ischémiques	31	2.07	4.1%
Les hydrocéphalies	29	1.93	3.9%
Neuropathies périphériques (+ Guillain-Barré)	25	1.67	3.3%
La SEP	24	1.60	3.2%
Le syndrome parkinsonien	24	1.60	3.2%
Céphalées et algies de la face	22	1.47	2.9%
Spina bifida	19	1.27	2.5%
Malformations de la charnière crania-cervicale	19	1.27	2.5%
La SLA	17	1.13	2.3%
Syndrome de compression médullaire	17	1.13	2.3%
Les craniosténoses	15	1.00	2.0%
Ataxies cérébelleuses	14	0.93	1.9%
Sciatique par hernie discale	13	0.87	1.7%
Syndrome de la queue de cheval	13	0.87	1.7%
TOTAL leçons au programme (22)	726 Q	48.4	96.8%

PARTIE 3 — QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (ORDRE STRICT PAR RANG)

Format : faits (-) / pièges (Δ) / source (□) / lien cours (□) / citations (□)

[RANG 1] PATHOLOGIES TUMORALES DU SNC

Pr. Ait Benali / Pr. Benantar • ~5.9 Q/examen (88 Q — 11.7%)

□ OMS 2021 des tumeurs du SNC • raisonner par TOPOGRAPHIE (étage) + ÂGE + bénin/malin

□ Correction Normal 2025 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

□ Correction Ratt 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Topographie — la question reine, posée à CHAQUE session :

- SUS-tentorial : méningiome (surtout), glioblastome, oligodendrogliome, astrocytome, craniopharyngiome, métastase
- SOUS-tentorial / FCP : médulloblastome (enfant, vermis/V4), épendymome, astrocytome pilocytique (enfant), schwannome vestibulaire + kyste épidermoïde (= angle ponto-cérébelleux)
- VENTRICULES : épendymome, papillome des plexus choïdes, kyste colloïde (V3)
- Région SELLAIRE : adénome hypophysaire, craniopharyngiome, méningiome supra-sellaire, gliome des voies optiques
- ENFANT : médulloblastome, craniopharyngiome, astrocytome pilocytique, gliome du tronc. ADULTE : méningiome, glioblastome, métastase, adénome, oligodendrogliome, schwannome
- Δ Méningiome/glioblastome/gliome/schwannome NE sont PAS ventriculaires
- Δ Schwannome NE se développe PAS dans la région sellaire ; médulloblastome n'est PAS une tumeur de l'APC (c'est le vermis)

□ Quasi chaque session 2017→N2025 (2 Q/an)

Méningiome intracrânien :

- Tumeur EXTRA-parenchymateuse (extra-axiale, née de l'arachnoïde), plus fréquente à l'étage SUS-tentorial
- Généralement bénin mais PEUT être malin (grade II-III OMS) ; peut envahir os/voûte et sinus duraux
- Révélation : cécité (compression optique), épilepsie, céphalées, troubles mnésiques/du langage, troubles endocriniens (supra-sellaire) ; souvent de découverte fortuite (TCC)
- Traitement : exérèse chirurgicale ; bon pronostic si exérèse complète ; méningiomatose possible
- Δ « Toujours bénin » FAUX • « intra-parenchymateux » FAUX • « plus fréquent sous-tentorial » FAUX
- Δ « Nécessite TOUJOURS la chirurgie » FAUX (petit/asymptomatique → surveillance) • chimiothérapie NON standard

□ Posé presque chaque année (N2017→N2025)

Glioblastome :

- Tumeur gliale de HAUT GRADE (IV OMS), de l'ADULTE, essentiellement SUS-tentorielle, diffuse/infiltrante, souvent nécrotico-hémorragique
- Traitement = association CHIRURGIE + RADIOTHÉRAPIE + CHIMIOTHÉRAPIE (protocole de Stupp) ; mauvais pronostic
- Δ « Bénin / bas grade » FAUX • « de l'enfant » FAUX • « du tronc cérébral » FAUX (= DIPG)
- Δ « Bien circonscrit / plan de clivage » FAUX • « évolution lente / bon pronostic » FAUX

□ Chaque session (souvent 1 Q/an)

Schwannome vestibulaire (neurinome de l'acoustique) :

- Tumeur BÉNIGNE du nerf VESTIBULAIRE (VIII), dans l'angle ponto-cérébelleux / conduit auditif interne, croissance lente, UNILATÉRALE
- Bilatéral = neurofibromatose type 2 (NF2)
- Révélation : hypoacousie de perception unilatérale, acouphènes, vertige/troubles de l'équilibre, paralysie faciale (VII), névralgie faciale (V), troubles de déglutition (IX-X si volumineux)
- Δ « Tumeur du nerf facial » FAUX (c'est le VIII) • « souvent bilatérale » / « évolution rapide » FAUX

- **⚠️ ⚠️ Corrigé N2021 a coté « épilepsie » VRAI : anomalie — une tumeur de l'APC ne donne PAS d'épilepsie (vérifier)**

□ N2017→N2025

Médulloblastome :

- Tumeur MALIGNE embryonnaire de l'ENFANT, FCP (vermis cérébelleux / 4e ventricule)
- S'accompagne SOUVENT d'hydrocéphalie (obstruction du V4) ; dissémination par le LCR
- Traitement = chirurgie + radiothérapie + chimiothérapie
- **⚠️ « Bénin » / « tumeur de l'APC » / « chirurgie seule » FAUX**

□ N2017, R2017, N2019-2025 (récurrent)

Astrocytome pilocytique de la FCP de l'enfant :

- Tumeur de BAS GRADE (I OMS), souvent kystique à nodule mural, cérébelleuse
- BON pronostic : exérèse chirurgicale souvent curative (pas de chimio/radio si exérèse complète)
- **⚠️ ⚠️ Corrigé officiel Oct/Nov 2024 cote « mauvais pronostic » VRAI : ERREUR probable — bas grade = BON pronostic (vérifier avec le Pr)**
- **⚠️ « Du tronc cérébral » FAUX (= DIPG) • « de l'APC » FAUX**

□ Oct2024 Q9, Nov2024 Q9

Métastases cérébrales — indications chirurgicales :

- Opérer si : lésion UNIQUE + primitif CONTRÔLÉ + risque d'engagement + doute diagnostique
- Sujet âgé, AEG, métastases viscérales multiples (poumon + foie) → PALLIATIF : antalgiques + corticothérapie + soins de confort (± antiépileptiques si crise)
- **⚠️ Chez le sujet âgé en AEG : exérèse / biopsie stéréotaxique / bronchoscopie FAUX**
- **⚠️ « Abstention thérapeutique totale » FAUX (on traite les symptômes)**

□ Vignette « octogénaire tabagique + lésion cérébelleuse + opacités thoraciques » : N2017→N2020, R2018

Adénome hypophysaire / craniopharyngiome / oligodendrogliome :

- Adénome : révélé par BAV/cécité (hémianopsie bitemporale par compression chiasmatique), paralysie oculomotrice, syndrome endocrinien (aménorrhée-galactorrhée + stérilité = prolactinome ; acromégalie ; Cushing)
- Craniopharyngiome : région sellaire/supra-sellaire de l'ENFANT, bénin, calcifié, troubles visuels + insuffisance hypophysaire + diabète insipide
- Oligodendrogliome : révélé par ÉPILEPSIE, souvent CALCIFIÉ, sus-tentorial
- **⚠️ Adénome révélé par une paraplégie FAUX**

□ R2017 Q19, N2018 Q41, N2018 Q38

[RANG 2] PATHOLOGIES INFECTIEUSES DU SNC

Pr. Benantar / Pr. Louhab • ~5.5 Q/examen (83 Q — 11.1%) — fusion des 2 tags « infectieuses » (51 + 32)

□ 4 entités : suppurations (abcès/empyème) • tuberculose • hydatidose • neurosyphilis

□ Correction Normal 2025 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

□ Correction Ratt 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Suppurations intracrâniennes — définitions (très posées) :

- ABCÈS cérébral = collection purulente INTRA-parenchymateuse
- EMPYÈME = collection purulente EXTRA-cérébrale : SOUS-durale ou EXTRA-durale
- URGENCE neurochirurgicale ; triade de BERGMANN (HTIC + syndrome infectieux + signes de localisation)
- Portes d'entrée : otite, sinusite, foyer dentaire, plaie crânio-cérébrale/post-trauma, endocardite (hémotogène) — recherche CAPITALE
- Scanner : lésion hypodense avec prise de contraste ANNULAIRE (cocarde) + œdème. Bilan : TDM + NFS + hémocultures

- Traitement : ANTIBIOTHÉRAPIE (probabiliste puis adaptée à l'antibiogramme) + symptomatique + traitement de la porte d'entrée ; chirurgie si compression/échec/doute/augmentation de taille
- ⚠ « *Abcès = collection extra-parenchymateuse* » FAUX (c'est l'empyème) ; « *abcès = hématique* » FAUX
- ⚠ « *Antibiothérapie contre-indiquée / sans place* » FAUX • « *abcès : TOUJOURS chirurgie* » FAUX • « *touche uniquement l'immunocompétent* » FAUX
- ⚠ *Cause d'abcès : MAV ou athérome carotidien* FAUX

□ Définitions reposées N2024-25, N2020, N2019 ; portes d'entrée R2017, Nov2024

Tuberculose du SNC :

- BK = Mycobacterium tuberculosis, bacille ACIDO-ALCOOLO-RÉSISTANT, croissance LENTE ; atteinte par dissémination HÉMATOGÈNE (foyer pulmonaire)
- Manifestations les + fréquentes : méningite tuberculeuse + tuberculomes ; tableau POLYMORPHE selon la localisation
- Confirmation = nécrose CASÉEUSE (anatomopath) et/ou isolement du BK (LCR, crachats, biopsie)
- Facteurs favorisants : immunodépression, contage, bas niveau socio-économique, absence de BCG, ATCD perso/familial, grossesse, tabagisme, diabète
- Traitement : anti-bacillaires ≥ 9 mois (souvent 12) + symptomatique ; chirurgie si compression / échec / doute / hydrocéphalie (TOUJOURS associée aux anti-bacillaires)
- ⚠ « *Touche uniquement le rachis* » / « *traitement uniquement médical* » / « *uniquement chirurgical* » FAUX
- ⚠ TDM « *pose le diagnostic avec certitude* » FAUX • *vasospasme comme indication chirurgicale* FAUX • *bon niveau socio-économique* FAUX

□ Quasi chaque session (indications chirurgicales N2021-2025, facteurs Nov2024)

Tuberculome encéphalique :

- Lésion tuberculeuse (PAS une mycose, PAS une parasitose) ; peut SIMULER un abcès ou une métastase à l'imagerie
- Anti-bacillaires ≥ 9 mois ; chirurgie parfois (compression/doute)
- ⚠ « *S'associe TOUJOURS à une TBC pulmonaire / à une méningite tuberculeuse* » FAUX
- ⚠ « *Mycose fréquente au Maroc* » / « *traitement 2 ans* » / « *toujours chirurgical* » FAUX

□ N2017-2018, R2017-2018

Méningite tuberculeuse — LCR (récurrent) :

- Liquide CLAIR, hyperprotéinorachie (souvent > 1 g/L), HYPOglycorachie, cytorachie LYMPHOCYTAIRE ; syndrome méningé SUBAIGU ; méningite de la BASE → atteinte des nerfs crâniens
- ⚠ « *Glycorachie normale* » FAUX • *liquide « purulent / trouble »* FAUX • « *riche en BK à l'examen direct* » FAUX • *début « brutal/aigu »* FAUX

□ N2017-2019, R2017-2019, N2024

Hydatidose cérébrale et vertébro-médullaire :

- Forme LARVAIRE d'Echinococcus granulosus ; homme = hôte INTERMÉDIAIRE accidentel (ingestion d'œufs) ; chien = hôte définitif
- Structure : adventice + cuticule + membrane prolifère + liquide hydatique + sable hydatique
- CÉRÉBRAL : touche surtout l'ENFANT, souvent UNIQUE, BON pronostic ; révélé par HTIC/cécité/déficit
- VERTÉBRO-MÉDULLAIRE : localisation DORSALE la + fréquente, tableau de compression médullaire ou de queue de cheval, atteinte para-vertébrale, RÉCIDIVE fréquente
- Chirurgie sans rupture du kyste (technique de Dowling) ; exérèse partielle = source de récurrence ; ± albendazole
- ⚠ « *Localisation cervicale la + fréquente* » FAUX (= dorsale) • « *souvent multiple / cérébelleuse* » (cérébral) FAUX
- ⚠ « *Mycose* » FAUX (parasitose) • « *homme = hôte définitif* » FAUX

□ N2025 Q3, N2023 Q37, N2019-2020, R2019

Neurosyphilis :

- Atteinte neuro = apanage des stades SECONDAIRE (II) et TERTIAIRE (III)
- Méningo-vascularite (4-7 ans, sujet jeune 30-50 ans, territoire SYLVIE → AVC du jeune)

- Paralyse générale (méningo-encéphalite chronique) : 10-15 ans après le chancre, homme, INSTALLATION PROGRESSIVE, démence + délire de GRANDEUR + syndrome extrapyramidal (striatite) ; IRM = atrophie corticale (peut être normale)
- TABÈS : forme la + fréquente, ataxie PROPRIOCEPTIVE (Romberg + en rétropulsion, atteinte cordonale postérieure), douleurs fulgurantes, atteinte optique, arthropathie
- Signe d'ARGYLL-ROBERTSON : abolition du réflexe PHOTOMOTEUR + CONSERVATION de l'accommodation (myosis irrégulier)
- Dx : TPHA-VDRL sang puis CONFIRMATION dans le LCR (+ cytochimie) ; traitement = PÉNICILLINE G IV ($\pm$ ceftriaxone)
- **⚠ Paralyse générale « 2-3 ans après le chancre » FAUX (= 10-15 ans) • « installation aiguë » FAUX**
- **⚠ Argyll-Robertson = « mydriase aréactive » FAUX • ophtalmoplégie internucléaire → SEP (pas neurosyphilis) • traitement amox-clav / corticoïdes seuls FAUX**

□ N2017-2019, R2017-2019, N2022-2024 (vignettes tabès/PG)

[RANG 3] PATHOLOGIES TRAUMATIQUES (TC + RACHIS)

Pr. Ait Benali • ~4.7 Q/examen (71 Q — 9.5%)

□ Score de GLASGOW (GCS /15) • chir = instabilité ligamentaire OU compression neurologique

□ Correction Normal 2025 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

□ Correction Ratt 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Score de Glasgow (GCS) — calcul + gravité :

- TC GRAVE si GCS $\leq 8/15$ (« inférieur à 8 »)
- Décérébration (extension) = M2 ; décortication (flexion) = M3
- Yeux fermés (Y1) + aucun son (V1) + décérébration (M2) = 4/15
- Yeux fermés (Y1) + aucun son (V1) + décortication (M3) = 5/15 ; + sons incompréhensibles (V2) + décérébration (M2) = 5/15
- GCS = 3 minimum (1+1+1)
- **⚠ Inverser décortication (M3) et décérébration (M2) = piège classique de calcul**

□ Calcul GCS à chaque session (N2017→N2025)

Lésions crâniennes CHIRURGICALES vs surveillance :

- CHIRURGIE : HSD aigu avec effet de masse/déviation de la ligne médiane ; HSD chronique ; plaie crânio-cérébrale (même par balle) ; embarrure ouverte ; HED COMPRESSIF ; brèche ostéo-méningée avec rhinorrhée INTARISSABLE ou méningite à répétition
- SURVEILLANCE / médical : HSD aigu sans effet de masse ; œdème cérébral ; CONTUSION (tronc, cérébelleuse, insulaire) ; hématome PROFOND (thalamique, tronc, mésencéphalique = inaccessible) ; rhinorrhée qui SE TARIT ; hémorragie méningée traumatique ; hémosinus ; plaie punctiforme du scalp
- **⚠ Hématome du TRONC / thalamique = NON chirurgical (inaccessible) — piège fréquent**
- **⚠ Rhinorrhée qui se tarit = surveillance ($\neq$ intarissable) • « lame d'HED » : opérer si compressive seulement**

□ Quasi chaque session

Lésions RACHIDIENNES — stable (orthopédie) vs instable (chirurgie) :

- CHIRURGIE (instabilité/déficit) : luxations (C4C5, D10D11, C7D1, rotatoire C1C2 avec atteinte ligamentaire) ; fracture des PÉDICULES de C2 (bipédiculaire) ; odontoïde déplacée / avec déficit / rupture du ligament transverse ; fracture TEAR-DROP cervicale ; tassement $> 50\%$; fracture comminutive avec fragment intra-canalair ou syndrome de queue de cheval ; fracture pathologique/métastatique avec épidurite ; plaie vertébro-médullaire
- STABLE (contention) : entorse bénigne C4C5 ; fracture isolée des apophyses ÉPINEUSES ou TRANSVERSES ; arc (ant. ou post.) de C1 sans atteinte ligamentaire ; tassement antérieur minime ($< 50\%$) ; fracture de la POINTE de l'odontoïde ; sacrum non déplacé
- **⚠ Apophyses épineuses/transverses isolées = STABLE (piège quasi annuel)**
- **⚠ Principe : opérer si atteinte ligamentaire/luxation/déplacement OU compression neurologique**

□ Quasi chaque session

Complications post-opératoires :

- Opéré du CRÂNE : œdème cérébral, hématome post-op, méningite, fistule de LCR, ostéite du volet, thrombose des sinus duraux, hydrocéphalie, atteinte des paires crâniennes, épilepsie
- Opéré du RACHIS : hématome épidural, spondylodiscite, instabilité vertébrale, fistule/brèche de LCR, épidurite, ischémie médullaire, déficit neurologique

□ N2019, Nov/Oct2024, Ratt2024, N2025 (souvent toutes vraies)

[RANG 4] PATHOLOGIES NEUROMUSCULAIRES

Pr. Louhab • ~4.1 Q/examen (62 Q — 8.3%)

□ EMG : MYOGÈNE (PUM brefs, tracé riche) vs MYASTHÉNIQUE (décrément) vs NEUROGÈNE

□ Correction Normal 2025 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

□ Correction Ratt 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Syndrome MYOGÈNE (myopathie) — clinique + paraclinique :

- Déficit moteur PROXIMAL (ceintures), marche dandinante, signe de GOWERS, signe du TABOURET, pseudo-hypertrophie des mollets ; ROT présents ; sensibilité CONSERVÉE ; pas de fasciculations
- Paraclinique : CPK élevée, EMG MYOGÈNE (PUM de faible amplitude/brève durée, tracé riche à l'effort minime), conduction nerveuse NORMALE
- Bilan : EMG + CPK + biopsie musculaire + étude génétique
- **▲ Bilan : anti-RACH / TDM hanche / calcémie / bilan lipidique / TDM rachis = HORS sujet**

□ Signes myogènes N2017, Nov2024, N2025 ; EMG R2017-2019, N2019

Myopathie de DUCHENNE / Becker :

- DUCHENNE : dystrophinopathie liée à l'X (garçons), dystrophine TOTALEMENT ABSENTE ; la + fréquente et la + sévère de l'enfant ; début ~3 ans, perte de la marche ~12 ans ; CPK > 10x ; cardiomyopathie FRÉQUENTE, mauvais pronostic
- PEC Duchenne : multidisciplinaire — kiné (rétractions), corticothérapie (retarde la perte de marche), périndopril/IEC (atteinte cardiaque), bilan cardio + respiratoire
- BECKER : même gène (DMD), dystrophine DIMINUÉE (pas absente), début plus tardif, évolution plus lente, meilleur pronostic
- **▲ Duchenne « fréquente chez les filles / cardiomyopathie rare / bon pronostic / débute à 15 ans / absence de mérosine » FAUX**
- **▲ Becker « dystrophine totalement absente » FAUX (= Duchenne)**

□ N2017, N2019, N2024-25, R2024, Nov2024

Syndrome MYASTHÉNIQUE (myasthénie auto-immune) :

- Atteinte EXCLUSIVEMENT MOTRICE, FLUCTUANTE, aggravée à l'EFFORT et en fin de journée ; ptosis fluctuant/à bascule, diplopie, atteinte oculomotrice NON systématisée, troubles de déglutition ; réflexe PHOTOMOTEUR CONSERVÉ
- EMG = DÉCRÉMENT à la stimulation répétitive (bloc post-synaptique), conduction normale ; tests : anti-RACH / anti-MuSK, test au GLAÇON, prostigmine, TDM THORACIQUE (thymome)
- Traitement : anticholinestérasiques (Mestinon) + corticoïdes + immunosuppresseurs (azathioprine) + thymectomie ; CRISE → réanimation + échanges plasmatiques ou Ig IV + éducation
- **▲ Déficit proximal / Gowers / Tabouret / marche dandinante / fasciculations / atteinte sensitive = FAUX pour la myasthénie (→ myogène ou neurogène)**
- **▲ « Photomoteur aboli » / « aggravation au repos » FAUX • ANXIOLYTIQUES = facteur de décompensation (jamais en traitement)**

□ Très récurrent : N2017-2018, N2019-2020, N2024-25, R2024

Syndrome de LAMBERT-EATON :

- Syndrome myasthénique PRÉ-synaptique (Ac anti-canaux calciques), PARANÉOPLASIQUE (cancer bronchique à petites cellules) ou non

- Faiblesse proximale + aréflexie ; FACILITATION post-effort (la force AUGMENTE après l'effort) — inverse de la myasthénie

□ N2023 Q21

[RANG 5] LES ÉPILEPSIES

Pr. Chraa • ~2.8 Q/examen (42 Q — 5.6%)

□ ILAE : idiopathique-génétique (bon pronostic) vs lésionnelle/sympt. (pharmacorésistance)

□ Correction Normal 2025 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

□ Correction Ratt 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Syndromes IDIOPATHIQUES / génétiques :

- Épilepsie myoclonique juvénile (EMJ), absences de l'enfant/infantiles (pointes-ondes 3 c/s), épilepsie à paroxysmes ROLANDIQUES, absences juvéniles ; pronostic généralement BON
- EMJ : myoclonies surtout MATINALES, EEG polypointes-ondes, rythme de fond NORMAL, examen normal hors myoclonies
- Absence de l'enfant : suspension de conscience BRÈVE (< 1 min) sans chute, EEG pointes-ondes 3 c/s déclenchées par l'hyperpnée, souvent méconnue à l'école
- ⚠ **Épilepsie temporale débutant à 30 ans = LÉSIONNELLE (pas idiopathique) • syndrome de West = sympt./lésionnel**
- ⚠ **Temporale sur sclérose de l'hippocampe = souvent PHARMACORÉSISTANTE**

□ Classification posée quasi chaque année (N2020→N2024, R2024, Nov2024)

Traitement — enfant, épilepsie myoclonique avec absences :

- À PRESCRIRE : VALPROATE de sodium, LÉVÉTIRACÉTAM (Keppra), benzodiazépine (Diazépam/Valium)
- Femme en âge de procréer : préférer lévétiracétam/lamotrigine (valproate tératogène)
- ⚠ **CARBAMAZÉPINE, PHÉNYTOÏNE, PHÉNOBARBITAL = AGGRAVENT les absences et les myoclonies (piège majeur, posé chaque année)**

□ N2017-2018, N2023, R2017-2019-2024, Nov2024

Antiépileptiques — effets indésirables :

- TÉRATOGENES : valproate (++), carbamazépine, phénytoïne, phénobarbital ; faible risque : lamotrigine, lévétiracétam
- SÉDATIFS : phénobarbital, carbamazépine, valproate, phénytoïne (les « anciens »)
- Valproate : hépatotoxicité, prise de poids, tremblement, tératogénicité ; phénobarbital : sédation, algodystrophie

□ N2017, N2022-2023, N2019, Nov2024

Diagnostic de crise + déficit post-critique :

- Arguments de crise : morsure LATÉRALE de langue, stéréotypie, aura (déjà-vu, pesanteur épigastrique = temporale), CGTC
- Confusion + hémiplégie post-critique (Todd) en contexte APYRÉTIQUE → DD : déficit post-critique, AVC, neuro-Behçet, hypoglycémie ; bilan : glycémie capillaire + ionogramme + imagerie + EEG
- ⚠ **Encéphalite herpétique = contexte FÉBRILE (écartée si apyrétique) • ne pas démarrer un traitement de fond après UNE seule crise**

□ N2018-2020, N2025 Q43-44

[RANG 6] PATHOLOGIES VASCULAIRES INTRACRÂNIENNES

Pr. Ghannane • ~2.3 Q/examen (35 Q — 4.7%)

□ HSA (hémorragie méningée) + hématome intracérébral spontané — ≠ AVC ischémique

□ Correction Normal 2025 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Hémorragie méningée (HSA) spontanée — diagnostic :

- Confirmer l'HSA : TDM cérébrale SANS injection (hyperdensité des espaces sous-arachnoïdiens) ; si TDM normale + forte suspicion → PONCTION LOMBAIRE (LCR sanglant/xanthochromique)
- Confirmer l'étiologie = ARTÉRIOGRAPHIE/angiographie cérébrale (recherche d'ANÉVRISME)
- Étiologie n°1 à éliminer = rupture d'ANÉVRISME
- ⚠ *Pour l'anévrisme : TDM/PL ne confirment pas (→ artériographie). Pour l'HSA : EEG/PE du tronc inutiles*

□ N2017→N2025 (alternance « suspicion HSA » / « suspicion anévrisme »)

Complications/aggravation d'une HSA :

- RESAIGNEMENT (récidive), VASOSPASME → ISCHÉMIE cérébrale (J4-J14), HYDROCÉPHALIE
- ⚠ *Épilepsie / démence / cécité / méningite = FAUX comme complications majeures*

□ N2018-2025 (quasi chaque année)

Hématome intracérébral spontané — étiologies :

- HTA (n°1, profond/capsulo-lenticulaire), MAV, cavernome, angiopathie amyloïde (âgé, lobaire), tumeur (saignement intra-tumoral), anticoagulants/AVK, maladies de système/Behçet, syphilis ; confirmer par TDM (± angio si MAV)
- ⚠ *Athérome carotidien (→ AVC ischémique) FAUX • « traitement par vitamine K » FAUX (ce sont les ANTI-vitamine K qui saignent)*

□ N2018-2024, R2019, R2024

[RANG 7] NEURO-BEHÇET

Pr. Chraa • ~2.1 Q/examen (32 Q — 4.3%)

□ Critères internationaux ICB (≥ 4) • aphtose buccale 2 + génitale 2 + neuro 1...

□ Correction Normal 2025 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

□ Correction Ratt 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Formes cliniques + IRM :

- 2 grands types : PARENCHYMATEUX (méningo-encéphalite du TRONC CÉRÉBRAL/diencéphale) et VASCULAIRE (THROMBOPHLÉBITE cérébrale)
- Atteinte du tronc, encéphalomyélite, méningite aseptique SUBAIGUË/chronique, pleurer/rire spasmodique, démence (évolution), atteinte extra-neuro (aphtose, uvéite)
- IRM : hypersignaux NON confluents, atteinte diencéphalo-mésencéphalique, atteinte des noyaux gris, thrombose veineuse
- ⚠ *Méningite aseptique « aiguë » FAUX (= subaiguë) • neuropathie périph./atteinte musculaire = RARES*
- ⚠ *Névrite optique rétrobulbaire / polyradiculonévrite = PAS Behçet (→ SEP/GBS) • hypersignaux confluents → SEP*

□ N2017-2022, R2017-2019

Localisation neuro-anatomique (vignette tronc récurrente) :

- Syndrome ALTERNE = hémicorps controlatéral + nerf crânien homolatéral → ex. hémiparésie gauche + III droit = MÉSENCÉPHALE DROIT (Weber)
- Limitation bilatérale de l'abduction (VI) dans un contexte d'HTIC = atteinte du VI par HTIC (« fausse localisatrice »), pas nucléaire
- DD d'un syndrome du tronc subaigu du sujet jeune : SEP, neuro-Behçet, processus infectieux

□ N2022-2024, R2024, Nov2024

[RANG 8] LES DÉMENCES

Pr. Chraa • ~2.1 Q/examen (31 Q — 4.1%)

□ Dégénératives (incurables) vs SECONDAIRES CURABLES (à chercher systématiquement)

□ Correction Normal 2025 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

□ Correction Ratt 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Critères diagnostiques / ce qui fait DOUTER :

- Démence = déclin cognitif ACQUIS, PROGRESSIF, DURABLE : trouble de la MÉMOIRE + autre fonction (apraxie/agnosie/aphasie/exécutif) + RETENTISSEMENT sur les activités
- **⚠ Fait DOUTER/écarter : syndrome CONFUSIONNEL (vigilance), trouble RÉCENT/aigu, agressivité/agitation récente, tableau dépressif (idées noires, isolement = pseudo-démence), trouble cognitif léger sans retentissement**
- **⚠ « Syndrome confusionnel » = toujours FAUX comme critère de démence**

□ N2017-2024 (chaque année)

Dégénératives vs CURABLES :

- DÉGÉNÉRATIVES (incurables) : Alzheimer (la + fréquente, au Maroc aussi), Huntington, fronto-temporale, corps de Lewy, vasculaire
- CURABLES (à rechercher) : carence en VITAMINE B12, HYPOTHYROÏDIE, HYDROCÉPHALIE chronique/HPN, NEUROSYPHILIS, neuro-VIH, neuro-Behçet, neuro-lupus, tumeur frontale, hématome sous-dural chronique
- Bilan : IRM encéphalique + TPHA-VDRL + vitamine B12 + TSH + sérologie VIH (± PL)
- **⚠ INCURABLES = Alzheimer + Huntington • DD : dépression, psychose, tumeur frontale (PAS aphasie sur AVC, PAS maladie du cervelet)**
- **⚠ Alzheimer : anticholinestérasiques (donépézil) / mémantine ; ÉVITER benzodiazépines et neuroleptiques classiques**

□ Curables/dégénératives N2017→N2024 (très répété)

Démence à corps de Lewy (vignette N2025) :

- Syndrome PARKINSONNIEN + HALLUCINATIONS VISUELLES + fluctuations cognitives + démence (+ sensibilité aux neuroleptiques) ; bilan EEG + IRM + PL + TPHA-VDRL/HIV

□ N2025 Q41-42

[RANG 9] LES AVC ISCHÉMIQUES

Pr. Chraa • ~2.1 Q/examen (31 Q — 4.1%)

□ Fenêtre THROMBOLYSE < 4h30 • thrombectomie < 6h • IRM diffusion = gold standard

□ Correction Normal 2025 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

□ Correction Ratt 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Généralités + AVC du SUJET JEUNE :

- AVCI = 80-85 % des AVC, 1ère cause de handicap moteur permanent, 2e cause de démence ; FDR : HTA (n°1), diabète, dyslipidémie, tabac, ACFA/cardiopathie emboligène
- Jeune : DISSECTION des troncs supra-aortiques (n°1), cardiopathie emboligène/ACFA, vascularites (Behçet, Gougerot), artérites infectieuses (syphilitique, tuberculeuse), thrombophilie/hyperviscosité ; bilan : écho-cœur + sérologie syphilitique + thrombophilie
- **⚠ SEP / myasthénie / dépression / Parkinson juvénile / rupture d'anévrisme = FAUX comme étiologie d'AVCI**

□ N2017-2024, R2017-2019

Traitement à la phase aiguë :

- THROMBOLYSE IV (< 4h30, hors CI) ; THROMBECTOMIE mécanique (occlusion proximale, < 6h) ; ANTIAGRÉGANT (aspirine) sinon ; STATINE si athérome ; ANTICOAGULANT curatif si ACFA et absence d'infarctus massif

- TA : on RESPECTE l'HTA à la phase aiguë (sauf > 220/120, ou > 185 si thrombolyse) ; UNV = meilleure structure ; vascularite → corticothérapie + aspirine
- **⚠ Au-delà de 4h30 / dans l'AIT : pas de thrombolyse • « corriger la moindre élévation à 170 » FAUX**
- **⚠ Artérite syphilitique : aspirine (pas d'extencilline ni d'anticoagulant à la phase aiguë)**

□ N2017-2024, R2024, Oct2024

Mécanismes + topographie + IRM :

- 4 mécanismes : petites artères (lacunes), thrombose in situ (athéro), EMBOLIE (cardiaque/artério-artérielle), HÉMODYNAMIQUE (bas débit/sténose serrée)
- Sylvienne : hémiplégie brachio-faciale + hémianesthésie + APHASIE (dominant) + hémignégligence (mineur). Vertébro-basilaire : ataxie, vertige, atteinte des nerfs crâniens, syndromes alternes (PAS d'aphasie)
- IRM = gold standard précoce : diffusion (premières minutes) + perfusion (pénombre), siège/collatéralité/thrombus
- **⚠ Thrombose veineuse (TVC) n'est PAS un mécanisme d'infarctus artériel**

□ N2021-2025 (topographie + IRM N2025)

[RANG 10] LES HYDROCÉPHALIES

Pr. Laghmari • ~1.9 Q/examen (29 Q — 3.9%)

- VCS si OBSTRUCTIVE (sténose aqueduc, tumeur) • DVP si COMMUNICANTE (post-HSA, post-méningite)
 - Correction Normal 2025 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)
 - Correction Ratt 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Hydrocéphalie du NOURRISSON :

- Étiologies : sténose de l'aqueduc de Sylvius (++) , post-méningite, post-hémorragie, tumeur du V4/plexus choïde (hypersécrétion)
- Clinique : MACROCRÂNIE progressive (signe le + fréquent), BOMBEMENT/tension des fontanelles, disjonction des sutures, regard en « coucher de soleil »
- Diagnostic : ÉCHOGRAPHIE TRANSFONTANELLAIRE (non invasive) ; traitement = DVP ou VCS
- **⚠ « Fontanelles déprimées » FAUX (= bombées) • « toujours associée à Chiari/Dandy-Walker/syringomyélie » FAUX**

□ N2019→N2025 (chaque année)

Hydrocéphalie active de l'ENFANT/ado vs chronique de l'ADULTE :

- ENFANT (sutures fermées) : tableau d'HTIC = céphalées (en casque) + vomissements + œdème papillaire au FO (pas de macrocrânie)
- ADULTE / HPN : triade d'ADAMS-HAKIM = troubles de la MARCHÉ + troubles SPHINCTÉRIENS + DÉMENCE (cause CURABLE) ; étiologies = post-HSA, post-méningite ; traitement = DÉRIVATION interne (DVP)
- **⚠ Adulte chronique « dû à une atrophie cérébrale » FAUX (= hydrocéphalie ex-vacuo) • antiépileptique / DVE FAUX**

□ Enfant N2019-2025 ; adulte N2017, R2017

Choix de la dérivation + complications de la DVP :

- DVP : hydrocéphalie COMMUNICANTE (chronique adulte, post-hémorragique, post-méningitique) ; VCS (ventriculocisternostomie) : hydrocéphalie OBSTRUCTIVE (sténose de l'aqueduc, tumeur de la région pinéale)
- Complications DVP : infection/méningite/ventriculite, péritonite, abcès, OBSTRUCTION de valve, hématome sous-dural chronique (hyperdrainage)
- **⚠ VCS pour les formes COMMUNICANTES (post-HSA/post-infectieuse) FAUX • kyste colloïde → exérèse, ventriculite → pas de matériel**

□ N2017 Q36-37, R2017 Q7

[RANG 11] NEUROPATHIES PÉRIPHÉRIQUES (+ GUILLAIN-BARRÉ)

Pr. Louhab • ~1.7 Q/examen (25 Q — 3.3%)

□ GBS = dissociation albumino-cytologique • jamais de corticoïdes

□ Correction Normal 2025 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

□ Correction Novembre 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Polyradiculonévrite aiguë = Syndrome de GUILLAIN-BARRÉ :

- Déficit moteur PROXIMO-DISTAL SYMÉTRIQUE, ASCENDANT, tétraparésie FLASQUE, ROT ABOLIS, RCP indifférent, SANS niveau sensitif ; souvent post-infectieux (grippal/gastro)
- Dx : ENMG (démýélinisation : ralentissement VCN, blocs) + LCR = DISSOCIATION ALBUMINO-CYTOLOGIQUE (protéinorachie ↑, cellules normales)
- Traitement : SOINS INTENSIFS (surveillance respiratoire) + Ig IV (0,4 g/kg/j × 5 j) OU échanges plasmatiques + rééducation
- ⚠ ROT vifs / Babinski = FAUX (central) • fasciculations = FAUX (corne ant.) • niveau d'anesthésie D6/D10 = FAUX (médullaire)
- ⚠ CORTICOÏDES = INEFFICACES/CI (≠ myasthénie) • thymectomie/cyclophosphamide FAUX

□ N2017, N2019, N2021, N2023, Nov2024, N2025 Q30-32

Étiologies + formes topographiques (diabétique) :

- Étiologies : DIABÈTE (n°1), insuffisance rénale, alcool, carences (B1/B12), médicaments (ISONIAZIDE, vincristine/cisplatine, antirétroviraux), VIH, vascularites/Gougerot
- POLYNEUROPATHIE : troubles distaux symétriques « en chaussettes », ENMG anormale
- NEUROPATHIE DES PETITES FIBRES : brûlures des pieds, examen ET ENMG NORMAUX
- MONONEUROPATHIE MULTIPLE : atteinte ASYMÉTRIQUE successive de plusieurs troncs (médian puis fibulaire) ; bilan glycémie/HbA1c + rénal + NFS-VS-CRP
- ⚠ SEP / Parkinson = FAUX (centraux) • isoniazide → compléter en B6

□ N2018-2025, Nov2024 Q34-35

[RANG 12] LA SCLÉROSE EN PLAQUES (SEP)

Pr. Chraa • ~1.6 Q/examen (24 Q — 3.2%)

□ Critères de McDonald : dissémination SPATIALE + TEMPORELLE (IRM)

□ Correction Normal 2025 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

□ Correction Ratt 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Signes évocateurs + IRM (vs Behçet) :

- Névrite optique rétrobulbaire, OPHTALMOPLÉGIE INTERNUCLÉAIRE (très évocatrice), syndrome cérébelleux, signe de LHERMITTE, syndrome de sclérose combinée de la moelle, syndrome pyramidal (parfois isolé/asymptomatique)
- IRM : hypersignaux CONFLUENTS, RESPECT des noyaux gris, atteinte JUXTA-corticale et périventriculaire ; bilan = IRM + PL (bandes oligoclonales) + PEV + biopsie glandes salivaires/anti-SSA-SSB (éliminer Gougerot)
- ⚠ Ptosis (myasthénie), dissociation/troubles syringomyéliques (syringomyélie), anesthésie en chaussette (neuropathie), anesthésie en selle (queue de cheval), paralysie faciale périph., HTIC, uvéite (Behçet) = FAUX

□ N2017-2024, R2019

Névrite optique rétrobulbaire (NORB) + traitement :

- BAV souvent unilatérale, DOULEURS oculaires augmentées à la mobilisation du globe, dyschromatopsie ; FOND D'ŒIL NORMAL au début (atteinte rétrobulbaire), PEV = latences allongées

- Poussée = BOLUS de corticoïdes ; + traitement de FOND (immunomodulateurs) + symptomatique + rééducation
- ⚠ « Œdème papillaire au FO » au début : piège — le FO est NORMAL dans la NORB (corrigés contradictoires) • AINS FAUX

□ N2018, N2023, Nov2024, N2025 Q37-40

[RANG 13] LE SYNDROME PARKINSONNIEN

Pr. Chraa • ~1.6 Q/examen (24 Q — 3.2%)

□ Triade : AKINÉSIE/bradykinésie + RIGIDITÉ plastique ± TREMBLEMENT de repos

□ Correction Ratt 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

□ Correction Novembre 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Définition + MP typique vs secondaire :

- Syndrome parkinsonien = bradykinésie + RIGIDITÉ plastique (roue dentée) ± tremblement de REPOS
- MP idiopathique — arguments : ASYMÉTRIE, TREMBLEMENT DE REPOS, RÉPONSE à la L-DOPA ; anatomopath = corps de LEWY ; pas de traitement curatif
- MP typique du sujet âgé : AUCUN bilan nécessaire (diagnostic clinique)
- ⚠ Hypertonie SPASTIQUE (= pyramidale) / tremblement d'ACTION (= cérébelleux) FAUX • début bilatéral d'emblée FAUX

□ N2018-2025 (vignette « asymétrie + L-dopa » très répétée)

Syndromes secondaires + traitement :

- Secondaires (SUJET JEUNE → enquête) : NEUROLEPTIQUES (++) , maladie de WILSON (bilan cuprique), intoxications (MANGANÈSE, CO), vasculaire, post-trauma, tumeur des noyaux gris ; bilan jeune = IRM + cuprique + TPHA-VDRL + métaux lourds
- Traitement MP : L-DOPA, AGONISTES dopaminergiques (jeune), ANTICHOLINERGIQUES (Artane — CI chez le sujet âgé), AMANTADINE, kiné, CHIRURGIE (stimulation cérébrale profonde) aux stades évolués
- ⚠ Cannabis / magnésium / SEP / dépression FAUX • NEUROLEPTIQUES aggravent • corticoïdes/antispastique = aucune place

□ N2018-2024, R2017-2018-2024, Nov2024

[RANG 14] CÉPHALÉES ET ALGIES DE LA FACE

Pr. Chraa • ~1.5 Q/examen (22 Q — 2.9%)

□ Migraine 4-72h • aura 5-60 min • névralgie du V < 2 s • AVF 15-180 min

□ Correction Ratt 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

□ Correction Normal 2023 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Céphalée de tension vs MIGRAINE :

- TENSION : en casque/étau (non pulsatile), bilatérale, vertex/occiput, intensité FAIBLE-moyenne, PAS d'aggravation menstruelle, PAS d'aura
- MIGRAINE : PULSATILE, hémicrânie, intensité modérée-forte, 4-72 h, AGGRAVÉE par la menstruation, photo-phonophobie ; aura VISUELLE (scotomes 5-60 min) ou HÉMIPLÉGIQUE (déficit réversible 5-60 min)
- ⚠ Aura « quelques secondes » ou « > 4 h » FAUX (= 5-60 min) • céphalée de tension aggravée par les règles FAUX

□ N2017-2023, R2017-2019-2024

Névralgie du trijumeau : IDIOPATHIQUE vs SYMPTOMATIQUE :

- IDIOPATHIQUE : décharge électrique fulgurante < 2 s, ZONE GÂCHETTE, examen NORMAL, TRÈS BONNE réponse à la CARBAMAZÉPINE

- SYMPTOMATIQUE (lésionnelle) : ABSENCE de gâchette, fond douloureux PERMANENT, SIGNES PHYSIQUES (troubles sensitifs du V, réflexe cornéen aboli), MAUVAISE réponse à la carbamazépine → IRM
- ⚠ *Confondre les deux tableaux = piège • « gâchette + examen normal + bonne réponse » = idiopathique*

□ N2017-2023, R2017-2024

Drapeaux ROUGES d'une céphalée :

- Début BRUTAL en coup de tonnerre (→ HSA), AEG, déficit neuro/visuel PERMANENT, fièvre + syndrome méningé, âge > 50 ans (Horton), aggravation progressive, mauvaise réponse au traitement
- ⚠ « Intensité très forte » SEULE n'est PAS un drapeau rouge (migraine/névrалgie sont intenses mais bénignes)

□ N2021 Q25

[RANG 15] SPINA BIFIDA

Pr. Laghmari • ~1.3 Q/examen (19 Q — 2.5%)

□ Anomalie de fermeture du TUBE NEURAL (1er mois) • prévention = acide folique

□ Correction Normal 2025 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

□ Correction Ratt 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Définition + formes :

- Anomalie de fermeture du TUBE NEURAL au 1er MOIS de gestation
- MÉNINGOCÈLE (méninges + LCR, sans tissu nerveux) = BON pronostic neurologique ; MYÉLOMÉNINGOCÈLE (+ moelle/racines) = MAUVAIS pronostic (paraplégie, troubles sphinctériens, retard mental)
- Topographie lombo-sacrée la + fréquente ; associations : Chiari type II, HYDROCÉPHALIE, syndrome polymalformatif
- ⚠ « Malformation au 2e/3e trimestre » FAUX (= 1er mois) • « myéloméningocèle bon pronostic » FAUX • « toujours symptomatique » FAUX (occulta)

□ N2017-2025, R2019, Nov/Oct2024

Diagnostic + prévention + cause :

- Diagnostic ANTÉNATAL : échographie (dès le 2e trimestre) + IRM + ALPHA-FŒTOPROTÉINE ; bilan postnatal = IRM cérébro-médullaire
- PRÉVENTION = ACIDE FOLIQUE (B9) péri-conceptionnel ; cause = ANTIÉPILEPTIQUES (surtout VALPROATE), carence en folates, diabète maternel
- ⚠ « Prévention par vitamine C/D » FAUX (= acide folique) • « diagnostic impossible avant la naissance » FAUX

□ N2023-2025, Nov/Oct2024, Ratt2024

[RANG 16] MALFORMATIONS DE LA CHARNIÈRE CRANIO-CERVICALE

Pr. Laghmari • ~1.3 Q/examen (19 Q — 2.5%)

□ Classer OSSEUSES vs NERVEUSES (question stéréotypée quasi annuelle)

□ Correction Normal 2025 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

□ Correction Ratt 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Malformations OSSEUSES vs NERVEUSES :

- OSSEUSES : impression basilaire, PLATYBASIE, occipitalisation de l'atlas, OS ODONTOÏDEUM (défaut de fusion des points d'ossification de C2), fusion congénitale de 2 vertèbres (Klippel-Feil), dislocation C1-C2

- NERVEUSES : malformation d'ARNOLD-CHIARI (I et II), syndrome de DANDY-WALKER, SYRINGOMYÉLIE, SYRINGOBULBIE, moelle basse attachée
- **⚠ MYÉLOPATHIE CERVICARTHROSIQUE = dégénérative/acquise (PAS une malformation) — piège dans les DEUX listes**

□ Question osseuses/nerveuses quasi chaque année (N2020→N2025, R2024)

Révélation clinique + diagnostic :

- Cervicalgies, torticolis, dysmorphie occipito-cervicale, syndrome syringomyélique (dissociation thermoalgique, amyotrophie d'un MS), syndrome pyramidal/tétraparésie, syndrome cérébello-bulbaire, atteinte des nerfs MIXTES (IX-XII)
- Diagnostic : radiographie standard DYNAMIQUE (flexion-extension) + TDM (osseux) + IRM (nerveux)
- **⚠ Épilepsie / paralysie oculomotrice = FAUX (pas la charnière) • « toujours cause d'hydrocéphalie » FAUX**

□ N2017-2019, N2025 Q14

[RANG 17] LA SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE (SLA)

Pr. Louhab • ~1.1 Q/examen (17 Q — 2.3%)

□ Atteinte **SIMULTANÉE** motoneurone **CENTRAL** + **PÉRIPHÉRIQUE**

□ Correction Normal 2025 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

□ Correction Ratt 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Tableau positif :

- Atteinte du motoneurone **CENTRAL** (syndrome pyramidal : ROT VIFS, spasticité, Babinski) ET **PÉRIPHÉRIQUE** (AMYOTROPHIE, FASCICULATIONS, déficit moteur) — coexistence très évocatrice
- Forme bulbaire : dysarthrie, fausses routes, fasciculations + amyotrophie de la **LANGUE** ; l'amyotrophie peut précéder le déficit
- ENMG = atteinte diffuse de la corne antérieure ; IRM + LCR pour éliminer les DD ; pas de biopsie musculaire
- **⚠ Trouble de l'équilibre (cérébelleux) / atteinte sensitive profonde / atteinte extrapyramidale / hypertonie plastique = FAUX**

□ N2017, N2019-2025, R2017-2019-2024

Signes NÉGATIFS (critères d'exclusion) :

- PAS de troubles SENSITIFS, PAS d'atteinte OCULOMOTRICE, PAS de troubles SPHINCTÉRIENS (ces absences sont des items VRAIS récurrents)

□ Nov2024 Q32, N2025 Q34

[RANG 18] SYNDROME DE COMPRESSION MÉDULLAIRE

Pr. Ghannane • ~1.1 Q/examen (17 Q — 2.3%)

□ Topographie IRM : **EXTRA-durale** / **INTRA-durale** extra-médullaire / **INTRA-médullaire**

□ Correction Ratt 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

□ Correction Novembre 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Tableau + diagnostic :

- Syndrome **LÉSIONNEL** (radiculaire) + **SOUS-LÉSIONNEL** (pyramidal : para/tétraparésie SPASTIQUE, ROT vifs, clonus, Babinski) + **RACHIDIEN** + **NIVEAU SENSITIF** (ex. ombilic = D10)
- L'IRM médullaire est l'examen **CLÉ** ; **URGENCE** neurochirurgicale ; l'atteinte **PEUT** être réversible si décompression précoce
- **⚠ Troubles sphinctériens = TARDIFS (piège — vs queue de cheval où ils sont précoces)**
- **⚠ « PL s'impose en urgence » FAUX (CONTRE-INDIQUÉE) • « diagnostic sur TDM/radio standard » FAUX**

□ N2018-2024, R2018-2019, Nov2024

Étiologies par compartiment :

- EXTRA-DURALE : MÉTASTASE vertébrale (++), spondylodiscite/épidurite infectieuse (mal de Pott), hernie discale, sarcome d'Ewing, hématome épidural
- INTRA-DURALE EXTRA-MÉDULLAIRE : MÉNINGIOME rachidien, NEURINOME/schwannome
- INTRA-MÉDULLAIRE : ÉPENDYMOE, ASTROCYTOME
- ⚠ Spondylodiscite = EXTRA-durale (PAS intra-durale) • méningiome/neurinome = intra-dural extra-médullaire (PAS extra-dural) • épendymome/astrocytome = intra-médullaire • SLA n'est PAS une cause

□ R2017 Q23-24, N2019 Q19, N2023 Q44

[RANG 19] LES CRANIOSTÉNOSES

Pr. Farrouk • ~1.0 Q/examen (15 Q — 2.0%)

□ Corrélation SUTURE → FORME du crâne

□ Correction Normal 2025 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

□ Correction Ratt 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Suture → forme (correspondance à connaître) :

- SAGITTALE → SCAPHOCÉPHALIE (la + fréquente, crâne allongé)
- CORONALE unilatérale → PLAGIOCÉPHALIE antérieure ; LAMBDŌÏDE → plagiocéphalie postérieure
- DEUX coronales → BRACHYCÉPHALIE ; MÉTOPIQUE → TRIGONOCÉPHALIE ; PLUSIEURS sutures → OXYCÉPHALIE (turricéphalie, risque d'HTIC)
- ⚠ Craniosténose = fermeture prématurée d'une suture (PAS une microcéphalie)

□ Oxycéphalie/brachycéphalie/scaphocéphalie : N2017→N2025 (chaque année)

Formes SYNDROMIQUES (génétiqes) :

- CROUZON : faciocrâniosténose + hypoplasie de l'étage moyen de la face + EXORBITISME, SANS syndactylie
- APERT : craniosténose + SYNDACTYLIES + hypoplasie faciale ; traitement = chirurgical
- ⚠ Crouzon avec syndactylie FAUX (= Apert) • « sporadique » FAUX (génétiqes)

□ N2017 Q35, Nov2024 Q8

[RANG 20] ATAXIES CÉRÉBELLEUSES

Pr. Louhab • ~0.9 Q/examen (14 Q — 1.9%)

□ Aiguë vs chronique • dégénérative vs sympt. • curable vs incurable

□ Correction Novembre 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

□ Correction Normal 2023 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Étiologies aiguës vs chroniques :

- AIGUËS : infarctus vertébro-basilaire, HÉMATOME du cervelet, poussée de SEP, cérébellite infectieuse
- CHRONIQUES : maladie de FRIEDREICH et SCA (dégénératives), atrophie post-ALCOOLIQUE, cérébellite PARANÉOPLASIQUE, malformation de la charnière (Chiari), tumeur
- ⚠ Tumeur / malformation de la charnière = causes CHRONIQUES (pas aiguës)

□ N2017, N2020-2023, R2017-2019, Nov2024

Dégénératif + pronostic :

- DÉGÉNÉRATIF = Friedreich, SCA (≠ infectieux, inflammatoire, tumoral, vasculaire)
- CURABLES/bon pronostic : cérébellite syphilitique (traitée tôt), AVC TRANSITOIRE du cervelet ; INCURABLES : dégénérescence spino-cérébelleuse, atrophie alcoolique, cérébellite paranéoplasique, métastase

□ N2017 Q2, R2017 Q36, N2018-2019 Q37

[RANG 21] SCIATIQUE PAR HERNIE DISCALE

Pr. Ghannane • ~0.9 Q/examen (13 Q — 1.7%)

- Indication chirurgicale = CLINIQUE (jamais l'image seule)
- Correction Normal 2025 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)
- Correction Ratt 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Traitement médical vs indications CHIRURGICALES :

- MÉDICAL (1ère intention) : repos, antalgiques, AINS, myorelaxants
- Les 3 sciaticques CHIRURGICALES : (1) PARALYSANTE — déficit moteur, STEPPAGE (releveur du pied/L5), monoparésie ; (2) syndrome de QUEUE DE CHEVAL — troubles sphinctériens, anesthésie en selle ; (3) HYPERALGIQUE — radiculalgie REBELLE au traitement bien conduit
- ⚠ *Signe de Lasègue (30°/50°/70°), signe de la SONNETTE, IMAGE d'une grosse hernie, raideur lombaire, RÉGRESSION sous traitement = NE sont PAS des indications chirurgicales*
- ⚠ *OPÉRER SUR LA SEULE IMAGERIE = piège majeur (l'indication est clinique)*

□ N2017-2025, R2017-2019-2024, Nov/Oct2024

[RANG 22] SYNDROME DE LA QUEUE DE CHEVAL

Pr. Ghannane • ~0.9 Q/examen (13 Q — 1.7%)

- Syndrome NEUROGÈNE PÉRIPHÉRIQUE (≠ compression médullaire = pyramidal)
- Correction Normal 2025 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)
- Correction Ratt 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Tableau clinique :

- Déficit moteur des MEMBRES INFÉRIEURS FLASQUE, ABOLITION des ROT (achilléens, rotuliens), ANESTHÉSIE EN SELLE (périnée/OGE/anus), troubles GÉNITO-SPHINCTÉRIENS PRÉCOCES (mictions impérieuses, incontinence/rétention) ; URGENCE neurochirurgicale
- ⚠ *PAS de syndrome pyramidal : Babinski / ROT vifs / clonus / spasticité = FAUX (c'est PÉRIPHÉRIQUE)*
- ⚠ *Déficit des MS / trépidations épileptoïdes / niveau sensitif xiphoïdien = FAUX*

□ N2018-2025, R2019, Nov/Ratt2024

PARTIE 4 — TOPICS HORS LEÇONS OFFICIELLES 2026 (COURS ANNULÉ)

⚠ DISCLAIMER — À LIRE AVANT D'UTILISER CETTE SECTION ⚠

These lessons are NOT in the 2026 exam program.

Cours annulé — NOT officially scheduled.

USE AT YOUR OWN RISK — BUT GOOD TO KNOW.

Ces topics représentaient historiquement ~3.2% des questions des examens passés. S'ils ne sont PAS au programme cette année, ils peuvent malgré tout :

- Apparaître en question résiduelle ou rattrapage
- Être recyclés à la dernière minute
- Servir de "culture générale" médicale

Topics hors programme 2026 (par fréquence décroissante) :

Topic (hors programme)	Total	Moy/exam
Les troubles du sommeil	15 Q	1.00
Questions inclassifiables / cas composites	9 Q	0.60

[HORS 1] LES TROUBLES DU SOMMEIL

15 questions — 1.00 Q/examen (testé jusqu'en 2024)

- Correction Ratt 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)
- Correction Octobre 2024 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Parasomnies du sommeil lent profond :

- SOMNAMBULISME (marche nocturne, attitudes automatisées) = sommeil LENT PROFOND ; DANGER si on cherche à le forcer/réveiller → sécuriser l'environnement, ne pas contrarier ; benzodiazépine (Valium) SI fréquent ; pas d'hospitalisation, pas de Modafinil
- SOMNILOQUIE (parler en dormant) : souvent physiologique chez l'enfant ; BRUXISME (grincement) : peut altérer la dentition ; DD = épilepsie frontale nocturne si stéréotypé
- ⚠ Somnambulisme « concerne le sommeil paradoxal » FAUX (= lent profond) • Modafinil / hospitalisation en neurologie FAUX

□ N2017-2019, N2022-2024, Oct/Ratt2024

Hypersomnies + insomnie + facteurs :

- Somnolence diurne + accès de sommeil + IMC élevé → NARCOLEPSIE (cataplexie/chute de tonus, hallucinations hypnagogiques ; ttt Modafinil) ± SAHOS (obèse, ronflement) ; long dormeur = non pathologique
- INSOMNIE (réveil précoce, sommeil court non réparateur) : éviter les somnifères au long cours ; diagnostic clé = POLYSOMNOGRAPHIE
- Facteurs influençant NÉGATIVEMENT le sommeil : stress, climat chaud (PAS le sexe féminin ni l'alimentation végétarienne)

□ R2017, N2020-2021, N2024

[HORS 2] QUESTIONS INCLASSIFIABLES / CAS COMPOSITES

9 questions — 0.60 Q/examen (fragments de cas + rappels transversaux)

- Correction Normal 2025 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)
- Correction Normal 2018 ↗ : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Tumeur de la FCP de l'enfant (cas composite) :

- HTIC + syndrome cérébelleux STATIQUE (élargissement du polygone de sustentation, chutes dans tous les sens, sans trouble de coordination) + strabisme convergent (VI par HTIC) → tumeur de la FCP ; examen clé = IRM cérébrale

□ N2018 Q48-50

IRM dans l'AVC ischémique (bonus) :

- Gold standard du diagnostic PRÉCOCE : séquences DIFFUSION (premières minutes) et PERFUSION (zone de pénombre) ; précise le siège d'occlusion, la collatéralité et la taille du thrombus ; supérieure à la TDM pour les lacunes et la FCP

□ N2025 Q50

Rappels transversaux (cas N2025) :

- GBS post-grippal (tétraplégie flasque aréflexique, dissociation albumino-cytologique LCR) → soins intensifs + Ig IV ou plasmaphérèse — cf. rang 11
- Complications de l'opéré du crâne / du rachis — cf. rang 3

□ N2025 Q23-24, Q30-32

AIDE-MÉMOIRE FINAL — HIGH-YIELD CONCOURS NEUROLOGIE & NEUROCHIRURGIE

** CLASSIFICATIONS & SCORES À RETENIR **

Glasgow (GCS)	TC grave ≤ 8 • décérébration M2 / décortication M3
Tumeurs SNC	OMS 2021 • grade I→IV
Épilepsie	ILAE : idiopathique-génétique vs lésionnelle
Behçet	Critères ICBD ≥ 4 (aphtose buccale 2 + génitale 2 ...)
AVC	thrombolyse < 4h30 • thrombectomie < 6h
Craniosténoses	suture → forme (sagittale = scapho...)

** EXAMENS / MARQUEURS-CLÉ PAR PATHOLOGIE **

Marqueur / Critère	Indication
EMG : décrétement + bloc post-synaptique	MYASTHÉNIE
Anti-RACH / anti-MuSK + TDM thoracique	MYASTHÉNIE (thymome)
CPK ↑↑↑ + dystrophine absente	DUCHENNE
Dissociation albumino-cytologique (LCR)	GUILLAIN-BARRÉ
Argyll-Robertson (photomoteur aboli, accommodation OK)	NEUROSYPHILIS / tabès
LCR clair + hypoglycorachie + lymphocytaire	MÉNINGITE TUBERCULEUSE
Nécrose caséuse	TUBERCULOSE du SNC
Hypersignaux confluents, respect des noyaux gris	SEP (vs Behçet : non confluents + noyaux gris)
Asymétrie + tremblement de repos + réponse L-dopa	PARKINSON idiopathique
IRM diffusion/perfusion	AVC ischémique (gold standard)

** PIÈGES CLASSIQUES DU CONCOURS **

- ⚠ Carbamazépine / phénytoïne / phénobarbital AGGRAVENT absences et myoclonies (épilepsie généralisée idiopathique)
- ⚠ Guillain-Barré : corticoïdes INEFFICACES/CI (≠ myasthénie qui répond aux corticoïdes)
- ⚠ Anxiolytiques/benzodiazépines = facteur de décompensation de la myasthénie (à éviter)
- ⚠ Compression médullaire : PL CONTRE-INDIQUÉE, troubles sphinctériens TARDIFS — vs queue de cheval : sphinctériens PRÉCOCES
- ⚠ Sciatique : on opère sur la CLINIQUE (déficit, queue de cheval, hyperalgie rebelle), JAMAIS sur la seule image ni un Lasègue
- ⚠ Hématome du tronc / thalamique = NON chirurgical (inaccessible)
- ⚠ Méningiome/neurinome rachidien = intra-dural extra-médullaire ; spondylodiscite/métastase = extra-durale ; épendymome/astrocytome = intra-médullaire
- ⚠ Méningite TBC : glycorachie BASSE (jamais normale)
- ⚠ Astrocytome pilocytique de l'enfant = BON pronostic (corrigé local parfois erroné)
- ⚠ VCS (ventriculocisternostomie) si hydrocéphalie OBSTRUCTIVE ; DVP si COMMUNICANTE (post-HSA, post-méningite)

- **⚠ Myopathie acquise = inflammatoire/métabolique/toxique/endocrinienne (PAS les dystrophies, qui sont génétiques)**
- **⚠ Spina bifida = anomalie du tube neural (1er mois) ; prévention = ACIDE FOLIQUE (pas vit C/D) ; cause = valproate**

**** DISTINCTIONS & ENCHAÎNEMENTS CLÉS ****

- Syndrome MYOGÈNE (proximal, ROT présents, CPK↑, EMG riche) vs MYASTHÉNIQUE (fluctuant, photomoteur conservé) vs NEUROGÈNE (aréflexie, fasciculations)
- Syndrome ALTERNE du tronc : hémicorps controlatéral + nerf crânien homolatéral (ex. III + hémiplegie croisée = mésencéphale = Weber)
- Compression MÉDULLAIRE = syndrome pyramidal (ROT vifs, Babinski, niveau sensitif) ; QUEUE DE CHEVAL = périphérique (aréflexie, anesthésie en selle, sphinctériens précoces)
- SEP : dissémination SPATIALE et TEMPORELLE (NORB → OIN → myélite...)
- HSA : confirmer par TDM (± PL) ; anévrisme : confirmer par artériographie/angio ; complications = resaignement, vasospasme/ischémie, hydrocéphalie
- Tabès : chancre → (10-15 ans) → ataxie proprioceptive + Argyll-Robertson + arthropathie
- Hydrocéphalie : nourrisson = macrocrânie + fontanelles bombées ; enfant = HTIC ; adulte = triade d'Adams-Hakim (marche + sphincters + démence)

Généré par Claude.ai (Claude (Opus 4.8)) — Version 1

Cross-match 750 QEs officielles × Cours AIO Neuro + Neurochir (2 PDF officiels)

Pr. Chraa, Pr. Louhab (Neuro) • Pr. Ait Benali, Pr. Ghannane, Pr. Benantar, Pr. Laghmari, Pr. Farrouk (Neurochir)

Améliorations Version 1 :

- ✓ PARTIE 3 strictement par rang de fréquence (1→22)
- ✓ Déduplication des QCM répétés (clé officielle conservée)
- ✓ FAUX / pièges explicites avec ⚠
- ✓ Fusion des 2 tags « infectieuses » (83 Q)
- ✓ PARTIE 4 HORS programme séparée + disclaimer (troubles du sommeil testés jusqu'en 2024)
- ✓ Liens cliquables vers les corrections officielles e-qe.online par session